



Consenso sobre o uso de redes tansvaginais para correcção cirúrgica do Prolapso dos Órgãos Pélvicos (POP)

**Secção Portuguesa de Uroginecologia (SPUG) / Associação Portuguesa de
Neurourologia e Uroginecologia (APNUG)**

Documento de consenso sobre o uso de redes transvaginais na cirurgia de correcção do Prolapso dos Órgãos Pélvicos (POP)

Consensus document on the use of transvaginal meshes in surgical correction for Pelvic Organ Prolapse (POP)

Autores: Bercina Candoso*, Maria Geraldina Castro**, Ricardo Pereira e Silva***, Sofia Alegra****

* Assistente Graduada de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Materno Infantil do Norte – Centro Hospitalar e Universitário do Porto (CMIN-CHUP). Presidente da Secção Portuguesa de Uroginecologia (SPUG) e Membro dos Corpos Gerentes da Associação Portuguesa de Neurourologia e Uroginecologia (APNUG)

** Assistente Hospitalar Graduada de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). Tesoureira da SPUG e Membro dos Corpos Gerentes da APNUG.

*** Assistente Hospitalar de Urologia do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte (CHULN). Membro dos Corpos Gerentes da APNUG e da Associação Portuguesa de Urologia (APU). Assistente Convidado da Clínica Universitária de Urologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa.

**** Assistente Hospitalar de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Lusíadas Lisboa. Secretária Geral da SPUG

NOTA: Todos os autores reviram o manuscrito e aprovaram a versão final para publicação

NOTA: Os autores declaram não existir qualquer conflito de interesse

ORCID e Research ID – Bercina Candoso

<https://orcid.org/0000-0002-4724-3427>

<http://ResearchID.co/bercina.candoso>

<http://ResearchID.co/rid10241>

Endereço electrónico -bercina.candoso@gmail.com

Palavras-chave: Prolapso dos Órgãos Pélvicos, Próteses e Implantes, Cirurgia Vaginal

Keywords: Pelvic Organ Prolapse, Prostheses and Implants, Vaginal Surgery

Resumo

O Prolapso dos Órgãos Pélvicos (POP) é uma patologia que afecta uma grande percentagem de mulheres, apresentando graves repercussões na sua qualidade de vida. O tratamento desta patologia, passa, nos dias de hoje, pela utilização de redes transvaginais entre outras opções. Existe uma grande controvérsia em relação ao uso destas redes devido ao seu uso indiscriminado e a graves complicações que daí advieram.

Desta forma, a Secção Portuguesa de Uroginecologia da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, em conjunto com a Associação Portuguesa de Neurourologia e Uroginecologia, percebeu a necessidade de emitir recomendações sobre este assunto para apoiar os cirurgiões uroginecológicos, no uso de redes transvaginais em Portugal. Este documento visa defender a segurança do uso de redes no tratamento do POP no nosso país.

Abstract

Pelvic Organs Prolapse (POP) is a disease that affects a large percentage of women, with serious repercussions on their quality of life. The treatment of this pathology, nowadays, involves the use of transvaginal meshes, among other options. There is a great controversy regarding the use of these meshes due to their previous indiscriminate use and the serious complications that have resulted from it. Thus, the Portuguese Section of Urogynecology from Portuguese Society of Gynecology, together with the Portuguese Association of Neurourology and Urogynecology, concluded that there is an urgent need to issue recommendations on this subject to support urogynecological surgeons in the use of transvaginal meshes in Portugal. This document aims to increase the safety of the use of meshes in the treatment of POP in our country.

Contextualização e Normas de Orientação

1) O principal problema das cirurgias de correcção de POP com tecidos nativos, é a elevada taxa de recidiva e a potencial necessidade de nova correcção cirúrgica. Nos estudos longitudinais foram encontradas taxas de reintervenção variáveis entre 8,5 -58 % ^{(1) (2) (3)}.

A cirurgia com redes por via vaginal para correcção do POP surgiu inicialmente pela necessidade de aumentar a durabilidade da reparação efectuada. Efectivamente demonstraram uma menor taxa de recidiva, mas um maior número de complicações (11% comparativamente com 3,7%) com aumento do número de re-intervenções, ainda que uma parte significativa possa ser considerada cirurgia *minor* ^{(4) (5)}.

A disparidade de efeitos adversos publicados e a ausência desses em ensaios clínicos e estudos aleatorizados, com alguns tipos de redes e grupos de cirurgiões, sugere que as complicações não são generalizadas e poderão variar de acordo com o tipo de rede e experiência do cirurgião que procede ao implante ⁽⁴⁾.

2) As redes sintéticas transvaginais oferecem resultados anatómicos superiores à cirurgia com tecido nativo para o tratamento primário de prolapso do compartimento anterior, no entanto não há evidência científica na melhoria da qualidade de vida dos pacientes ⁽⁴⁾.

3) Em revisões da literatura científica baseadas em estudos internacionais, foram descritas taxas de complicações associadas à colocação de redes transvaginais sintéticas significativas, variando entre 10 a 15%. Algumas destas complicações podem ser graves e difíceis de solucionar com uma nova cirurgia, podendo comprometer a qualidade da vida da paciente permanentemente ^{(4) (5)}.

4) Com base nas evidências listadas acima, o tratamento de POP primário uni ou multicompartimental com utilização de redes na ausência de factores de risco específicos de recidiva, deve ser desencorajado ^{(6) (7)}.

5) O uso de redes sintéticas colocadas por via vaginal num POP primário pode ser apropriado e útil na presença de factores de risco significativos para recidiva: alterações do colagénio, DPOC, obesidade, obstipação crónica grave, hiato genital alargado com avulsão dos músculos elevadores do ânus ⁽¹⁾.

6) A correcção com rede do prolapso apical e /ou multicompartimental por via abdominal, tem elevadas taxas de sucesso e menor taxa de complicações relacionadas com redes ^{(8) (9)}.

7) Na presença do prolapso apical, a correcção com rede por via abdominal/laparoscópica, oferece elevadas taxas de sucesso e menor taxa de complicações relacionadas com a colocação da rede, no entanto pode não corrigir todos os defeitos compartimentais e posteriormente ser necessária a correcção por via vaginal com ou

sem rede. Esta técnica está também associada a maior tempo cirúrgico e recuperação mais prolongada, com todos os riscos de uma cirurgia abdominal / laparoscópica, ausentes na cirurgia vaginal. É obrigatório fornecer à doente um aconselhamento pré-operatório adequado e completo sobre todas as opções possíveis para a correcção do seu POP específico ^{(8) (9)}.

8) O tratamento do prolapso recorrente representa uma indicação para o uso de redes colocadas por via vaginal. Nestes casos os riscos associados à colocação da rede devem ser correctamente explicados à paciente, que deve dar o seu consentimento informado (ver consentimento nos Consensos em Uroginecologia, SPUG – SPG, Junho de 2018) ⁽⁶⁾⁽¹⁰⁾.

9) As redes devem ser utilizadas por cirurgiões com experiência no tratamento de prolapso complexo e recidivas, que tenham adquirido formação específica para cada dispositivo utilizado, com conhecimento alargado da anatomia pélvica e que demonstrem que dominam todas as técnicas de correcção de POP, assim como o reconhecimento de complicações intraoperatórias e capacidade de resolução das mesmas ^{(6) (11) (12) (13)}.

10) O tratamento do POP com rede por via vaginal deve ser realizado em centros em que se possa oferecer uma abordagem multidisciplinar com diferentes opções de tratamento. A decisão do tratamento deve ser partilhada com a doente depois de lhe ser bem explicado todas as opções terapêuticas e incluindo nesse esclarecimento a opção de não ser tratada. A doente aceitará os riscos e os benefícios destas abordagens em consentimento informado claro e preciso, já referido ^{(6) (13)}.

11) O Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR), da União Europeia e a European Urology Association (EAU) recomendam limitar a quantidade de rede em todos os procedimentos, o uso de um consentimento informado específico o mais esclarecedor possível, oferecendo todas as técnicas possíveis para a correcção do seu POP em concreto, o follow-up prolongado destas doentes, o registo das complicações em bases de dados previamente definidas e a implementação de um programa de certificação dos cirurgiões baseado nas directrizes internacionais em cooperação com as associações cirúrgicas europeias.

Recomenda ainda que as complicações decorrentes destas técnicas sejam resolvidas em centros com experiência neste campo ^{(13) (14)}.

12) A maioria dos “kits” de redes para tratamento do prolapso fornece fixação apical, pelo que a presença combinada de POP do compartimento anterior e apical e posterior e apical, pode ser resolvido com o uso destes dispositivos. No entanto não há evidência científica, por falta de estudos aleatorizados, que sustentem a superioridade anatómica do tratamento do POP apical com redes, comparado com a cirurgia transvaginal sem redes.

13) As redes por via vaginal só devem ser utilizadas na correcção do compartimento posterior, em casos muito seleccionados (Ex: Prolapso Grau IV, com componente apical, recidiva de prolapso, componente de enterocelo Grau IV, em doentes com obstipação crónica considerada grave e que entendam e aceitem os riscos e benefícios da correcção do seu POP, por esta via e com estas técnicas). Para a colocação destas redes os cirurgiões devem, reforçando o já acima referido, ter experiência na colocação das mesmas, já que as complicações de colocação de redes entre a vagina e o espaço para rectal se podem revestir de grande complexidade ⁽¹⁵⁾.

14) As redes para correcção de POP, podem ainda ser consideradas como primeira escolha, nas mulheres que tenham contra-indicação à correcção do seu prolapso por via abdominal ^{(1) (6) (7)}.

15) Os clínicos que se proponham corrigir os POP por via vaginal com estas redes, devem fazê-lo dentro de estudos aleatorizados ou ensaios clínicos e submeter estas doentes a consultas de *follow-up* a longo prazo ⁽⁶⁾.

16) Incentiva-se todos os cirurgiões/Instituições com experiência nestas técnicas de prolapso a certificarem-se como Centro de Referência para o tratamento das doentes⁽⁶⁾. A European Urogynaecology Association (EUGA) tem um programa de acreditação de Centros, na Subespecialidade de Uroginecologia, em conjunto com o European Board & College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG).

<https://www.eugaoffice.org/accreditationprogramme>

17) Recomenda-se que os Cirurgiões / Instituições, se submetam a auditorias internas, para avaliação dos resultados anuais. Recomenda-se ainda que utilizem a base de dados nacional para registo das suas complicações ⁽⁶⁾.

15) Põe-se como hipótese que as redes que utilizamos, nesta era da Uroginecologia, são mais biocompatíveis, mais leves e com maior porosidade que as redes que deram as altas taxas de complicações descritas na literatura. Espera-se que estas redes, sejam

mais seguras, melhorando consideravelmente o seu desempenho e segurança^{(16) (17) (18)}
^{(19)(20)(21)(22) (23)}.

Bibliografia:

- (1) Friedman T, Eslick GD, Dietz HP. Risk factors for prolapse recurrence: systematic review and meta-analysis. *Int Urogynecol J*. 2018 Jan;29(1):13-21.
- (2) Benson JT, Lucente V, McClellan E. Vaginal versus abdominal reconstructive surgery for the treatment of pelvic support defects: a prospective randomized study with long-term outcome evaluation. *Am J Obstet Gynecol*. 1996;175(6):1418-22.
- (3) Denman MA, Gregory WT, Boyles SH, Smith V, Edwards SR, Clark AL. Reoperation 10 years after surgically managed pelvic organ prolapse and urinary incontinence. *Am J Obstet Gynecol*. 2008;198(5): 555.e551-555. e555
- (4) Glazener CM, Breeman S, Elders A, Hemming C, Cooper KG, Freeman RM, et al; (PROSPECT study group). Mesh, graft, or standard repair for women having primary transvaginal anterior or posterior compartment prolapse surgery: two parallel-group, multicentre, randomised, controlled trials (PROSPECT). *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)*. 2013 Jun;42(4):334-41. doi: 10.1016/j.jgyn.2013.03.012. Epub 2013 Apr 2
- (5) Maher C, Feiner B, Baessler K, Christmann-Schmid C, Haya N, Marjoribanks J. Transvaginal mesh or grafts compared with native tissue repair for vaginal prolapse. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2016, Issue 2. Art. No.: CD012079. DOI: 10.1002/14651858.CD012079.
- (6) Aiste Ugianskiene, G. Willy Davila2, Tsung-Hsien, for the FIGO Urogynecology and Pelvic Floor Committee FIGO review of statements on use of synthetic mesh for pelvic organ prolapse and stress urinary incontinence. *Int J Gynecol Obstet* 2019; 1-9
- (7) Baeßler K et al. Diagnosis and Therapy of Female Pelvic Organ Prolapse... *Geburtsh Frauenheilk* 2016; 76: 1287-1301.
- (8) Lucot JP, et al; GROG (groupe de recherche en gynécologie et obstétrique). PROSPERE randomized controlled trial: laparoscopic sacropexy versus vaginal mesh for cystocele POP repair. *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)*. 2013 Jun;42(4):334-41. doi:10.1016/j.jgyn.2013.03.012. Epub 2013 Apr 22
- (9) Siddiqui NY, Grimes CL, Casiano ER, et al. Mesh sacrocolpopexy compared with native tissue vaginal repair: A systematic review and meta-analysis. *Obstet Gynecol*. 2015; 125:44-5
- (10) Consenso Nacional sobre Uroginecologia. Secção Portuguesa de Uroginecologia – Sociedade Portuguesa de Ginecologia. Junho de 2018
- (11) American Urological Association (AUA). AUA Position Statement on the Use of Vaginal Mesh for the Repair of Pelvic Organ Prolapse. <https://www.auanet.org/guidelines/use-of-vaginal-mesh-for-the-repair-of-pelvic-organ-prolapse>. Accessed May 10, 2017
- (12) The American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Joint Recommendations Issued on Use of Vaginal Mesh for POP. 2011. <http://www.acog.org/About-ACOG/News-Room/News-Releases/2011/Joint-Recommendations-Issued-on-Use-of-Vaginal-Mesh-for-POP>. Accessed May 10, 2017.
- (13) Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR). Opinion on the safety of surgical meshes used in urogynecological surgery. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenih_r_o_049.pdf. Accessed May 10, 2017
- (14) Chapple CR, Cruz F, Deffieux X, et al. Consensus statement of the European Urology Association and the European Urogynecological Association on the use of the implanted materials for treating pelvic organ prolapse and stress urinary incontinence. *Eur Urol* 2017; 72: 424-431.
- (15) Emil Nüssler & Gabriel Granäsén & Emil Karl Nüssler & Marie Bixo & Mats Löfgren Repair of recurrent rectocele with posterior colporrhaphy or non-absorbable polypropylene mesh—patient-reported outcomes at 1-year follow-up. *International Urogynecology Journal* (2019) 30:1679-1687
- (16) Patel H, Ostergard DR, Sternschuss G. Polypropylene mesh and the host response. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct*. 2012;23(6):669-79
- (17) Conze J, Rosch R, Klinge U, Weiss C, Anurov M, Titkova S, et al. Polypropylene in the intraabdominal position: influence of pore size and surface area. *Hernia*. 2004;8(4):365-72
- (18) Greca FH, De Paula JB, Biondo-Simões MLP, Da Costa FD, Da Silva APG, Time S, Mansur A. The influence of differing pore sizes on the biocompatibility of two polypropylene meshes in the repair of abdominal defects: experimental study in dogs. *Hernia*. 2001;5(2):59-64
- (19) Greca FH, Souza-Filho ZA, Giovanini A, Rubin MR, Kuenzer RF, Reese FB, Araujo LM. The influence of porosity on the integration histology of two polypropylene meshes for the treatment of abdominal wall defects in dogs. *Hernia*. 2008;12(1):45-9
- (20) Klinge U, Klosterhalfen B, Birkenhauer V, Junge K, Conze J, Schumpelick V. Impact of polymer pore size on the interface scar formation in a rat model. *J Surg Res*. 2002;103(2):208-14.
- (21) Gil Levy et al. Anchorless implant for the treatment of advanced anterior and apical vaginal prolapse – _Medium term follow up. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 246 (2020) 55-59
- (22) Paulo César Rodrigues Palma et al. Treatment of Anterior Vaginal Wall Prolapse Using Transvaginal Anterior Mesh With

- Apical Fixation: A Prospective Multicenter Study With up to 2 Years of Follow-up. Int Neurourol J 2018;22(3):177-184. <https://doi.org/10.5213/inj.1836036.018> pISSN 2093-4777 *§ eISSN 2093-6931
- (23) Andreas Brandt et al. Treatment of Pelvic Organ Prolapse using a lightweight modified HexaPro Mesh. Pelviperineology 2018; 37: 39-41 <http://www.pelviperineology.org>

Tipo de	Grau I/II	Grau III/IV	Recidiva Grau I/II	Recidiva Grau III	Recidiva Grau IV	Patologia pulmonar/ cardíaca /outra
prolapso						

POP anterior	Correcção com tecidos nativos	Correcção com tecidos nativos	Correcção com tecidos nativos	Correcção com tecidos nativos / correcção com rede por via vaginal	Correcção com rede por via vaginal	Correcção com rede por via vaginal
POP anterior e apical com Útero	Correcção com tecidos nativos	Sacrohisteropexia, Histeropexia por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE** / histerectomia vaginal	Correcção com tecidos nativos	Sacrohisteropexia, Histeropexia por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE* / histerectomia vaginal	Sacrohisteropexia, Histeropexia por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE / histerectomia vaginal	Histeropexia por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE* / histerectomia vaginal
POP anterior e apical sem Útero	Correcção com tecidos nativos	Sacrocolpopexia / Correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE**	Correcção com tecidos nativos	Sacrocolpopexia / Correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE*	Sacrocolpopexia / Correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE*	Correcção por via vaginal, com rede; com fixação ao LSE*
POP posterior	Correcção com tecidos nativos	Correcção com tecidos nativos	Correcção com tecidos nativos	Correcção com tecidos nativos/ correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE*	Correcção com tecidos nativos/ correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE*	Correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE*
POP posterior e apical com Útero	Correcção com tecidos nativos	Correcção com tecidos nativos / histerectomia vaginal / Correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE**	Correcção com tecidos nativos	Correcção com tecidos nativos / histerectomia vaginal / Correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE*	Correcção com tecidos nativos / histerectomia vaginal / Correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE*	Correcção com tecidos nativos / histerectomia vaginal / Correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE*
POP posterior e apical sem Útero	Correcção com tecidos nativos	Correcção com tecidos nativos / histerectomia vaginal / Correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE**	Correcção com tecidos nativos	Correcção com tecidos nativos / histerectomia vaginal / Correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE*	Correcção com tecidos nativos / histerectomia vaginal / Correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE*	Correcção com tecidos nativos / histerectomia vaginal / Correcção por via vaginal, com rede, com fixação ao LSE*

LSE – Ligamento sacroespinhoso

* Escolha da doente depois de bem informada, sobre riscos / benefícios.

** - Doente com factores de risco de recidiva que entenda os riscos/ benefícios e opte pela técnica

Tabela I – Orientações em cirurgia de correcção de prolapso dos órgãos pélvicos